

où on va aller rechercher le silence de la zone C par rapport à la zone A sur le plan diaphragmatique. Il y a un point de silence dans la pièce. À un moment donné, je vais vous guider. On va partir du neutre. On va laisser petit à petit le neutre du patient se développer. On va se mettre sur le champ micro-cristallin. On prend tout l'espace. Le film sur l'alkydo. Pour avoir une action thérapeutique le plus efficace possible, je dois arriver à avoir un neutre. Ensuite, il est important de pouvoir faire émerger chez mon patient ce neutre. C'est quelque chose qui doit mûrir. Pour ça, il faut le meeting point, le point de rencontre. Une fois que j'ai un point de rencontre, la personne en confiance peut petit à petit se désengager, se laisser aller, aller vers son neutre. Petit à petit, ces deux neutres vont commencer à se mélanger. Une fois que ces deux neutres vont se mélanger, j'ai un espace, une émergence plus visible, qui peut apparaître, ce qu'on appelle la respiration primaire. La respiration primaire, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans le corps, c'est présent partout. C'est un peu comme le souffle de vie. On va juste se mettre dans la conscience de cette cavité amniotique, cette zone B. Et en même temps, petit à petit, on va dissocier notre attention pour aller sur les piliers diaphragmatiques. Le point le plus fixe de mon diaphragme, ce sont des piliers. Et on va voir que finalement, on va avoir un neutre. Ce sont des points d'appui énormes, presque un point silencieux. Et on va petit à petit, avec un peu de patience, faire émerger le neutre de façon plus large. C'est-à-dire qu'on va utiliser aussi le silence cristallin. On va plutôt parler de l'immobilité cristalline de la pièce. Il y a une espèce de, dans la zone C, il y a une espèce d'immobilité qu'on doit voir. Et on va laisser le corps se centrer par rapport à cette zone C. Même si ça paraît subtil, ça va se faire tout seul sur un plan fluidique, comme électrique. Et puis on va petit à petit, dans cette pratique, commencer à faire confondre ce silence de la pièce, ou cette immobilité dynamique de la pièce, avec l'immobilité dynamique au niveau des

piliers diaphragmatiques. Tout en étant conscient de la cavité amniotique et de toute l'intégration de ma vésicule viteline pour former mon système veineux. Dans cette pratique, de toute façon, on va se faire confondre ce silence de la pièce avec l'immobilité dynamique de la pièce. Totalement vous abandonner à la respiration primaire, au mouvement présent, à la marée, c'est-à-dire à la force thérapeutique, à la puissance. Et laisser petit à petit voir ce que ça peut faire. Le mueil, dans le non-agir, c'est-à-dire je ne viens pas induire, je fais confiance à l'ostéopathe.